HLAVNÍ MATERIÁL

120 šablon hotových popisů

120 šablon popisů pro RTG, CT, MR a UZ/Doppler. Pole Metodika, Porovnání, Nález a Závěr jsou připravena; vy vyplňujete pouze hranaté závorky. Cíl: popis, který váš školitel / atestovaný radiolog nemusí přepisovat od nuly.

Obsah

Jak používat šablony

Část 1 · RTG (rentgenový snímek) — 30 šablon

Část 2 · CT — 35 šablon

Část 3 · MR — 25 šablon

Část 4 · UZ a Doppler — 30 šablon

Další krok

ÚVODEM

Jak používat šablony

Každá šablona je písemnou podobou 4krokové metody: PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE.

> *Šablona nenahrazuje přemýšlení; umožní vám sepsat vaše úvahy kompletně a v pořadí, které váš školitel očekává.*

POLE ŠABLONY	KROK V METODĚ	CO NAPÍŠETE
Technika	PŘIPRAVTE	Vyšetření, projekce nebo sekvence, kontrastní látka a fáze, technická kvalita. Pokud je nedostatečná, uveďte to jasně.
Porovnání	POPIŠTE · Porovnejte	Datum a modalita předchozího vyšetření; pokud chybí, uveďte „k porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření“.
Nález	PROJDĚTE + POPIŠTE	Každou oblast pokaždé ve stejném pořadí; správný termín (denzita / signál / echogenita), lokalizace, velikost, ohraničení. Uveďte i významná negativa.
Závěr	SHRŇTE	Odpověď na klinickou otázku, nejdůležitější nález na prvním místě, v případě potřeby diferenciální diagnóza a doporučení. Při urgentním nálezu uvést, komu a v kolik hodin byl hlášen.

Hranaté závorky

V šablonách **[vpravo / vlevo]**, **[.. mm]**, **[datum]**, **[hodin]** jsou pole specifická pro pacienta. Možnosti jsou uvedeny s lomítkem: ponechte vyhovující, ostatní smažte. Před podepsáním popisu nesmí v textu zůstat žádná hranatá závorka.

1. **Zvolte správnou šablonu** — podle vyšetření a hlavního nálezu. U normálního vyšetření začněte šablonou «Normální».
2. **Vyplňte pole Technika a Porovnání** — pokud jste předchozí vyšetření skutečně otevřeli, uveďte jeho datum.
3. **Upravte nález podle svého systematického zhodnocení** — nález, který v šabloně není, doplňte; nález, který nevidíte, smažte.
4. **Závěr formulujte podle klinické otázky** — můžete použít vhodnou větu z Databanky 200 závěrů popisu.

5 **Použijte jednostránkový kontrolní seznam popisu** — poté podepište nebo odešlete svému školiteli.

Past kopírování a vkládání

Chyby ve stranách, rozměrech a datech nejčastěji vznikají z textu ponechaného ze šablony. Každou větu v šabloně jednotlivě ověřte podle zobrazeného nálezu; nenechávejte nic jen proto, že «je to v šabloně», pokud to sami nevidíte.

Praxe vašeho pracoviště má přednost

Pokud se formát popisu, klasifikační systémy a terminologie používané na vašem pracovišti liší od těchto šablon, vždy se řiďte formátem vašeho pracoviště. Šablony si podle toho upravte.

ČÁST 1

RTG (rentgenový snímek)

30 šablon: 4 normální, 26 častých nálezů ve službě a v rutině.

001 PA RTG hrudníku · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: RTG hrudníku dospělých při bolesti na hrudi, kašli či předoperačním vyšetření bez zjištěné patologie.

Technika: RTG hrudníku v PA projekci ve stoje. Inspirium a penetrace dostatečné, bez výraznější rotace.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Trachea ve střední čáře. Velikost srdce v normálních mezích. Mediastinum a hilové struktury obvyklého vzhledu. V parenchymu obou plic bez konsolidací, expanzí či uzlů. Kostofrenické úhly jsou volné. Pneumotorax nezastižen. Brániční kopule hladce konturované. Na zobrazeném skeletu bez zjevné patologie.

Závěr: Na RTG hrudníku nebyla zjištěna akutní kardiopulmonální patologie.

002 Nativní RTG břicha ve stoje · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: RTG snímky bez patologie při vylučování obstrukce nebo volného vzduchu u bolestí břicha.

Technika: Nativní RTG břicha ve stoje; brániční kopule v zorném poli.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Pod bránicí není patrný volný plyn. Nezastiženy dilatované střevní kličky s hladinkami. Plyn v tračníku a rektu je přítomen. Bez zřetelných rentgenkontrastních konkrementů. Stíny psoatů jsou diferencovatelné. Zobrazené kostní struktury jsou bez nápadností.

Závěr: Na nativním RTG břicha nezjištěny známky obstrukce ani volného plynu.

003 RTG zápěstí · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: RTG zápěstí po pádu nebo distorzi bez patrné fraktury či luxace.

Technika: [Vpravo/Vlevo] AP a bočný RTG snímek zápěstí.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V oblasti distálního radia, ulny a karpálních kůstek není patrná čerstvá lomná linie. Radiokarpální a interkarpální kloubní štěrbiny jsou zachovány, osové postavení je normální. Měkké tkáně bez zjevného prosáknutí.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] V oblasti zápěstí nebyla zjištěna akutní kostní patologie. Při klinickém podezření na frakturu skafoidu nelze okultní frakturu na RTG vyloučit; doporučuje se klinické sledování a případně doplňující vyšetření.

004 RTG kolene · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy po traumatu nebo s bolestí kolene, kde není patrná kostní patologie.

Technika: [Vpravo/Vlevo] RTG kolena v AP a bočné projekci.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bez známek fraktury či luxace. Tibiofemorální i patelofemorální kloubní štěrbiny jsou zachovány. V suprapatelární oblasti bez přesvědčivých známek efuze. Mineralizace skeletu je přiměřená.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] na RTG snímku kolena nebyla zjištěna akutní kostní patologie.

005 PA RTG hrudníku · Pneumotorax

Kdy se používá: Případy s bolestí na hrudi, dušností, po traumatu či intervenci, kde je patrná pleurální linie. Může vyžadovat hlášení.

Technika: RTG hrudníku v PA projekci ve stoje.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v hemitoraxu je přítomen pneumotorax bez patrné plicní cévní kresby zevně od pleurální linie; vzdálenost pleurální linie od hrudní stěny v úrovni apexu [.. mm]. Posun mediastina [nepřítomno / ke kontralaterální straně]. Fraktura žebra [nepřítomna / na ... žebru].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] pneumotorax. Radiologické známky tenze [není/je]. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

006 RTG hrudníku · Známky tenzního pneumotoraxu

Kdy se používá: Případy rozsáhlého pneumotoraxu doprovázeného přetlačením mediastina. Tenzní pneumotorax je klinická diagnóza; léčba může předcházet snímkování.

Technika: [PA/lůžkový AP] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v hemitoraxu rozsáhlý pneumotorax; ipsilaterální plíce kolabována k hilu. Mediastinum a průdušnice přetlačeny na kontralaterální stranu, ipsilaterální bránice oploštělá, mezižeberní prostory rozšířené.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] rozsáhlý pneumotorax a radiologické známky tenzního pneumotoraxu. Urgentní nález; klinickému týmu [hodin] telefonicky hlášeno.

007 PA RTG hrudníku · Pleurální výpotek

Kdy se používá: Případy se zastřením kostofrenického úhlu nebo meniskoidním lemem.

Technika: Ve stoje PA [± bočná projekce] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo/Bilaterálně] otupení kostofrenického úhlu a opacita s konkávním horním okrajem tvaru menisku; [malé/střední/velké množství] množství odpovídá pleurálnímu výpotku. V přilehlé plíci nelze odlišit podkladovou konsolidaci. Mediastinum [obvyklý / přetlačený na kontralaterální stranu].

Závěr: [Vpravo/Vlevo/Bilaterálně] [malé/střední/velké množství] množství pleurálního výpotku. Základní parenchymovou patologii nelze na snímku vyloučit; doporučena klinická a v případě potřeby UZ korelace.

008 PA RTG hrudníku · Lobární konsolidace

Kdy se používá: Případy s horečkou, kašlem a nálezem opacity obsahující vzdušný bronchogram.

Technika: Ve stoje PA [± bočná projekce] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [horní/střední/dolní] v laloku oblast homogenní konsolidace se vzdušným bronchogramem. Objem laloku je zachován.
[Bez doprovodného pleurálního výpotku/malé množství pleurálního výpotku].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lalok] konsolidace; v korelaci s klinickým stavem může odpovídat pneumonii. Radiologická kontrola po léčbě se doporučuje dle klinického uvážení.

009 PA RTG hrudníku · Atelektáza

Kdy se používá: Případy opacity provázené známkami ztráty objemu.

Technika: Ve stoje PA [± bočná projekce] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [lalok] zastření se ztrátou objemu v ...; ve fisuře [dislokace], v ipsilaterálním hilu [nahoru/dolů] retrakce a elevace hemidiafragmy.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lalok] známky odpovídající atelektáze. K vyloučení centrální obstrukční příčiny se doporučuje klinická korelace a v případě potřeby CT hrudníku.

010 RTG hrudníku · Kardiomegalie

Kdy se používá: Případy, kdy je na PA snímku srdeční stín zvětšený. Na AP snímku může být velikost srdce zavádějící; uveďte to v popisu.

Technika: [PA/AP] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Kardiotorakální index je zvýšen. Plicní cévní kresba [obvyklý / zvýrazněný]. Pleurální výpotek [nepřítomno/...].

Závěr: Kardiomegalie [Na PA snímku]. Odlišení od perikardiálního výpotku nelze na RTG snímku provést; při klinické indikaci se doporučuje korelace s echokardiografií.

011 RTG hrudníku · Plicní edém

Kdy se používá: Případy s podezřením na dušnost, srdeční selhání nebo objemové přetížení.

Technika: [PA/lůžkový AP] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Oboustranné perihilózní opacity tvaru motýlích křídel; zmnožená intersticiální kresba (Kerleyho B linie), peribronchiální zesílení a kraniální redistribuce plicního cévního řečiště. Bilaterálně [v malém množství] pleurální výpotek. Velikost srdce [zvýšený/v normě].

Závěr: Nález svědčící pro plicní edém; může odpovídat kardiogennímu edému. Doporučena klinická korelace.

012 PA RTG hrudníku · Plicní expanze

Kdy se používá: Případy, kde vidíte okrouhlou, ohraničitelnou opacitu.

Technika: RTG hrudníku v PA a bočné projekci ve stoje.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [horní/střední/dolní] v zóně [.. mm] o velikosti, [hladký/laločnatý/spikuliformní] ohraničená, okrouhlá opacita. Kalcifikace [nepřítomno]. Hilové nebo mediastinální rozšíření [není/je]. Pleurální výpotek [není/je]. Destrukce sousedních žeber [nepřítomno].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] plíce [zóna] v [.. mm] ložisková expanze. K podrobnějšímu dovyšetření se doporučuje CT hrudníku s kontrastní látkou.

013 PA RTG hrudníku · Kavitující léze

Kdy se používá: Případy, kdy vidíte ohraničenou lézi s obsahem vzduchu.

Technika: Ve stoje PA [± bočná projekce] RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [horní/střední/dolní] stěna v zóně [tenký/tlustý, nepravidelný] kavitovaná léze; s hladinkou tekutina–plyn [přítomen/nepřítomen]. V okolí [konsolidace/nodulární opacity].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [zóna] kavitující léze v ... V diferenciální diagnóze přicházejí v úvahu infekční procesy včetně tuberkulózy, plicní absces a kavitující neoplazie; doporučena klinická a mikrobiologická korelace a CT hrudníku.

014 RTG hrudníku · Fraktura žebra

Kdy se používá: Případy po traumatu hrudníku, kde je patrné porušení kortikalis.

Technika: PA RTG hrudníku [± RTG žeber].

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [..]. žebro [anteriorní/laterální/posteriorní] v oblouku [nedislokovaná/dislokovaná] lomná linie. Pneumotorax nezastižen. Pleurální tekutina svědčící pro hemotorax [není/je]. Podkožní emfyzém [není/je].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [..]. fraktura žebra; doprovodný pneumotorax nezastižen. Senzitivita RTG snímku pro zobrazení fraktur žeber je omezená.

015 Lůžkový RTG hrudníku · Poloha endotracheální kanyly

Kdy se používá: Pacienti na JIP a urgentním příjmu po intubaci, u nichž je požadována kontrola polohy kanyly.

Technika: Lůžkový AP RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Konec endotracheální kanyly je od kariny [.. cm] nad ..., v tracheální střední čáře. [Konec nazogastrické sondy v projekci žaludku.] Pneumotorax nebyl zjištěn. [Bez nově vzniklých opacit.]

Závěr: Hrot endotracheální kanyly je od kariny [.. cm] nad [ve správné poloze]. / Hrot kanyly [pravý hlavní bronchus] v projekci ...; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

016 Lůžkový RTG hrudníku · Centrální žilní katétr

Kdy se používá: Kontrola polohy hrotu a vyloučení pneumotoraxu po zavedení CŽK.

Technika: Lůžkový AP RTG hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [vnitřní jugulární/podklíčková] hrot centrálního žilního katétru zavedeného cestou... [horní dutá žíla / kavoatriální junkce] je v projekci ... Pneumotorax nebyl zastižen. Mediastinum je bez nového rozšíření.

Závěr: Hrot CŽK [horní dutá žíla] v projekci ... Pneumotorax v souvislosti s výkonem nebyl zastižen.

017 RTG hrudníku · Poloha nazogastrické sondy

Kdy se používá: Případy s požadavkem na kontrolu polohy hrotu nasogastrické sondy před zahájením enterální výživy.

Technika: Lůžkový AP RTG hrudníku a horní části břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Nazogastrická sonda probíhá ve střední čáře ve stopě jícnu, prochází bránicí a její hrot se zobrazuje v levém horním kvadrantu v projekci žaludku.

Závěr: Hrot nazogastrické sondy v projekci žaludku. / Hrot sondy [pravý hlavní bronchus / jícen] v projekci ..., není ve správné poloze; před použitím klinickému týmu [hodin] hlášeno.

018 RTG snímek ve stoje · Pneumoperitoneum

Kdy se používá: Případy, kdy u akutního břicha vidíte volný vzduch pod bránicí. Vyžaduje urgentní hlášení.

Technika: RTG hrudníku ve stoje / nativní RTG břicha ve stoje.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Bilaterálně] pod bráničním klenbou je patrné projasnění odpovídající volnému vzduchu.

Závěr: Pneumoperitoneum (volný vzduch). Pokud není v anamnéze nedávný chirurgický či intervenční výkon, je doporučeno urgentní klinické zhodnocení k vyloučení perforace dutého orgánu. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

019 Nativní RTG břicha ve stoje · Obstrukce tenkého střeva

Kdy se používá: Případy přicházející pro zvracení, distenzi břicha a zástavu odchodu plynů a stolice.

Technika: Nativní RTG břicha ve stoje [± vleže].

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Centrálně uložené dilatované kličky tenkého střeva s patrnými valvulae conniventes a hydroaerickými hladinami v různých výších. Plyn v tračníku [snížený/nezastižen]. Pod bránicí není volný vzduch.

Závěr: Nález svědčící pro obstrukci tenkého střeva. K posouzení výše překážky, příčiny a komplikací doporučeno CT břicha s kontrastní látkou.

020 Nativní RTG břicha · Podezření na volvulus sigmatu

Kdy se používá: Případy s výraznou distenzí, zejména u starších pacientů s nálezem obrovské kličky tračníku.

Technika: Ve stoje [± vleže] nativní RTG břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Výrazně dilatovaná kličky tračníku tvaru obráceného U se ztrátou haustrace, sahající z pánve do horního kvadrantu (obraz kávového zrna).

Závěr: Nález svědčí pro volvulus sigmatu. Doporučeno akutní klinické vyšetření; k potvrzení a posouzení komplikací lze zvážit CT. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

021 Nativní nefrogram · Rentgenkontrastní konkrement

Kdy se používá: Případy s bolestí v boku, kde vidíte opacitu v projekci ledviny nebo podél průběhu močovodu.

Technika: Nativní nefrogram (nativní RTG močového traktu).

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [ledvina/průběh ureteru/pánvička] v projekci [.. mm] o velikosti ..., sytá denzita.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lokalizace] v projekci ... denzita odpovídající rentgenkontrastní litiáze. K odlišení flebolitu a posouzení obstrukce se doporučuje korelace s UZ nebo nativním CT.

022 RTG zápěstí · Fraktura distálního radia

Kdy se používá: Případy, kdy je po pádu na ruku patrná linie fraktury v distálním radiu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] AP a bočný RTG snímek zápěstí.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v metafýze distálního radia, ke kloubní ploše [propagující se/nepropagující se], [dorzální/volární] lomná linie s angulací. Zlomenina processus styloideus ulnae [přítomno/nepřítomno]. Zkrácení radia [přítomen/nepřítomen].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] fraktura distálního radia ([intraartikulární/extraartikulární], [dorzální/volární] s angulací).

023 RTG zápěstí · Fraktura skafoidu

Kdy se používá: Případy s citlivostí ve foveola radialis, kde je patrná linie fraktury ve skafoidu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] AP, bočný snímek zápěstí a cílené projekce na skafoid.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Skafoideum [pas/proximální pól/distální pól] v úrovni [jemný/dislokovaný] lomná linie. Tukový proužek skafoidu [vyhlazený / zachovaný].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] skafoid [pas] fraktura. U fraktur proximálního pólu se doporučuje ortopedické sledování pro riziko avaskulární nekrózy.

024 RTG kyčle · Fraktura krčku femuru

Kdy se používá: Zejména starší pacienti přicházející s bolestí kyčle a neschopností chůze po pádu.

Technika: AP pánev a [vpravo / vlevo] bočné RTG snímky kyčle.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v krčku femuru [subkapitální / transcervikální / bazicervikální] lomná linie; [dislokovaná/nedislokovaná, zaklíněná]. Kyčelní kloub [kompatibilní].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] fraktura krčku femuru ([dislokovaná/nedislokovaná]). Pokud je RTG snímek negativní a klinické podezření vysoké, je s ohledem na okultní zlomeninu doporučena MR nebo CT.

025 RTG ramene · Glenohumerální luxace

Kdy se používá: Případy po traumatu ramene s inkongruencí hlavice humeru a glenoidu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] rameno AP a [skapulární Y / axiální] RTG snímky.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] hlavice humeru vůči glenoidu [anteroinferiorní/posteriorní] v oblasti; kongruence glenohumerálního kloubu je porušena. Fraktura velkého tuberkula [není/je]. [Hill-Sachs/Bankart] kostní změny svědčící pro [nepřítomno/přítomno].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [anteriorní/posteriorní] glenohumerální luxace. Doporučuje se kontrolní RTG snímek po repozici.

026 RTG hlezna · Fraktura maleolu

Kdy se používá: Případy s patrnou lomnou linií malleolu po distorzi.

Technika: [Vpravo/Vlevo] RTG hlezna v AP, mortise a bočné projekci.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [laterální kotník / distální fibula] v úrovni, syndesmózy [pod/v úrovni/nad] [šikmá / příčná] lomná linie. Fraktura mediálního kotníku [přítomen/nepřítomen]. Vidlicový prostor [symetrický / mediálně rozšířený]. Otok měkkých tkání.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [laterální kotník] fraktura; vidlice [zachován/rozšířen].

027 RTG bérce · Fraktura diafýzy tibie

Kdy se používá: Případy se zlomeninou diafýzy tibie po vysokoenergetickém traumatu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] RTG bérce v AP a bočné projekci (včetně kolena a hlezna).

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] tibie [proximální / střední / distální] v ... třetině diafýzy [příčná/šikmá/spirální/tříštivá] fraktura; [.. mm] dislokace a [anteriorní/posteriorní] angulace. Fibula [intaktní / fraktura]. Plyn v měkkých tkáních [není/je].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] fraktura diafýzy tibie ([typ fraktury]); fibula [intaktní / fraktura]. Při přítomnosti plynu v měkkých tkáních se doporučuje klinická korelace k vyloučení otevřené fraktury.

028 RTG kolene · Osteoartróza

Kdy se používá: Pacienti s chronickou bolestí kolene bez akutního traumatu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] koleno [vstoje] AP a boční snímky.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v koleni [mediální / laterální] zúžení tibiofemorální kloubní štěrbiny, marginální osteofyty a subchondrální skleróza. Akutní fraktura nezastižena.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] v koleni [převaha v mediálním kompartmentu] degenerativní změny (osteoartróza). Akutní kostní patologie nebyla zjištěna.

029 RTG lokte (dětský věk) · Suprakondylická zlomenina humeru

Kdy se používá: Případy dětí s bolestí lokte po pádu, kde je patrná linie fraktury nebo známka tukového polštářku.

Technika: [Vpravo/Vlevo] RTG lokte v AP a bočné projekci.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Na bočném snímku je patrná elevace předního tukového polštářku a diferencuje se zadní tukový polštářek. Přední humerální linie capitula [nepřesahuje střední třetinu]. V suprakondylární oblasti [jemný/dislokovaný] lomná linie [je patrný / nelze spolehlivě diferencovat].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] suprakondylická zlomenina humeru ([dislokovaná/nedislokovaná]). I když linie fraktury není patrná, příznak zadního tukového polštářku svědčí pro okultní frakturu; doporučeno ortopedické vyšetření.

030 RTG · Spolknuté rentgenkontrastní cizí těleso

Kdy se používá: Případy s anamnézou polknutí cizího tělesa, zejména dětští pacienti.

Technika: AP snímek zahrnující krk, hrudník a břicho [± bočná projekce] RTG snímek.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Horní/střední/distální část jícnu/žaludek/tenké střevo] v projekci [.. mm] rentgenkontrastní cizí těleso o velikosti ... Obraz dvojitého prstence / dvojité kontury [přítomen/nepřítomen]. Volný plyn nezastižen.

Závěr: [Lokalizace] v projekci ... rentgenkontrastní cizí těleso. Lokalizace v jícnu nebo podezření na knoflíkovou baterii je považováno za urgentní stav; klinickému týmu [hodin] hlášeno. Radiolucentní cizí tělesa nemusí být na RTG snímku patrná.

ČÁST 2

CT

35 šablon: 4 normální, 31 častých nálezů ve službě a v rutině.

031 Nativní CT mozku · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy, kdy nezjistíte patologii při bolesti hlavy, synkopě nebo lehkém traumatu hlavy.

Technika: Nativní CT mozku; axiální řezy hodnoceny v mozkovém a kostním okně.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bez známek intrakraniálního krvácení, expanzivního chování či přesunu středočárových struktur. Diferenciace šedé a bílé hmoty je zachována. Komorový systém a sulky jsou přiměřené šíře k věku. Bazální cisterny jsou volné. Bez fraktury kalvy. Zachycené paranazální dutiny a mastoidální sklípky jsou provzdušněné.

Závěr: Na nativním CT mozku nebyla zjištěna akutní intrakraniální patologie. Časná ischemická CMP nemusí být na nativním CT patrná; při přetrvávajícím klinickém podezření lze zvážit MR-DWI.

032 CT krční páteře (trauma) · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy po úrazu s otázkou na poranění krčního skeletu, kdy nevidíte patologii.

Technika: Nativní CT krční páteře; sagitální a koronární rekonstrukce, kostní okno a okno pro měkké tkáně.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Osové postavení krčních obratlů je zachováno. Akutní fraktura ani luxace nezastižena. Fazetové klouby jsou kongruentní. Kraniocervikální junkce v normě. Šíře prevertebrálních měkkých tkání je v normě.

Závěr: Na CT krční páteře nebyla zjištěna akutní traumatická kostní patologie. Ligamentózní poranění nelze pomocí CT zcela vyloučit; při neurologickém nálezu se doporučuje MR.

033 CT hrudníku · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: CT hrudníku z rutinních nebo neonkologických indikací, kde nezjistíte patologii.

Technika: [S IV kontrastem/Nativně] CT hrudníku; hodnoceno v mediastinálním a plicním okně.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V mediastinu nebyly zjištěny lymfatické uzliny patologické velikosti. Velikost srdce je normální, perikardiální výpotek není přítomen. Hlavní cévní struktury mají obvyklý kalibr. V plicním parenchymu nebyla zachycena konsolidace, expanze ani signifikantní nodulus. Pleurální výpotek ani pneumotorax nejsou přítomny. V zobrazeném horním břiše a na skeletu bez patrné patologie.

Závěr: Na CT hrudníku nebyla zjištěna signifikantní patologie.

034 CT břicha a pánve · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Kontrastní CT břicha a pánve bez akutní patologie u pacientů s bolestí břicha.

Technika: CT břicha a pánve s i.v. kontrastní látkou, portovenózní fáze. Perorální kontrastní látka [podáno/nepodáno].

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Játra, slezina, pankreas, nadledviny a ledviny normální velikosti a denzity; ložiskové léze nezjištěny. Žlučník obvyklého obrazu; intra- a extrahepatické žlučovody bez dilatace. Kličky střevní bez dilatace či zesílení stěny. Appendix [normálního vzhledu / nelze spolehlivě diferencovat, v pravém dolním kvadrantu nejsou známky zánětu]. Bez volné tekutiny a volného plynu. Bez patologicky zvětšených lymfatických uzlin. Močový měchýř v normě. Na skeletu bez ložiskových lytických či blastických změn.

Závěr: Na CT břicha a pánve nebyla zjištěna akutní patologie.

035 Nativní CT mozku · Epidurální hematom

Kdy se používá: Případy s bikonvexní hyperdenzní kolekcí po kraniotraumatu. Urgentní hlášení.

Technika: Nativní CT mozku; mozkové a kostní okno.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [temporální/parietální/frontální] v oblasti, nepřesahující sutury, bikonvexního (lentiformního) tvaru, v nejsilnějším místě [.. mm] hyperdenzní extraaxiální kolekce o velikosti ... V přilehlé kalvě [lineární lomná linie]. Posun střední čáry [.. mm]. Bazální cisterny [volný/vyhlazený].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [oblast] akutní epidurální hematom; [.. mm] přesun středočárových struktur. Akutní nález; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

036 Nativní CT mozku · Subdurální hematom

Kdy se používá: Případy se srpkovitou extraaxiální kolekcí, zejména u starších pacientů a pacientů na antikoagulační léčbě.

Technika: Nativní CT mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] podél konvexity hemisféry, přesahující sutury, srpkovitého tvaru, [hyperdenzní/izodenzní/hypodenzní/smíšené denzity] subdurální kolekce; v nejširším místě [.. mm]. Vyhlazení sulků, komprese ipsilaterální postranní komory a [.. mm] přesun středočárových struktur.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [akutní/subakutní/chronický/akutní na podkladě chronického] subdurální hematom; expanzivní chování [přítomen/nepřítomen]. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

037 Nativní CT mozku · Subarachnoidální krvácení

Kdy se používá: Případy, kdy vidíte hyperdenzitu v cisternách při náhle vzniklé kruté bolesti hlavy nebo po traumatu.

Technika: Nativní CT mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Bazální cisterny/Sylviovy rýhy/interhemisférická štěrbina/kortikální sulky] hyperdenzní subarachnoidální krvácení v... Intraventrikulární krvácení [není/je]. Dilatace komor [není/je]. Parenchymatózní hematom [není/je].

Závěr: [Difúzní/Fokální] subarachnoidální krvácení. Hydrocefalus [není/je]. Pokud není v anamnéze trauma, doporučuje se k vyloučení aneuryzmatu CT angiografie. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

038 Nativní CT mozku · Intracerebrální hemoragie

Kdy se používá: Případy, kdy u pacienta přicházejícího s akutním neurologickým deficitem vidíte intraparenchymový hyperdenzní hematom.

Technika: Nativní CT mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [bazální ganglia/thalamus/lobární/cerebelární] lokalizovaný, [.. × .. mm] hyperdenzní parenchymový hematom o velikosti ...; v okolí hypodenzní edém. Propagace do komorového systému [není/je]. Posun střední čáry [.. mm].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lokalizace] akutní intraparenchymový hematom. K vyloučení základní příčiny se dle klinického stavu doporučuje další dovyšetření. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

039 Nativní CT mozku · Časné známky ischemické cévní mozkové příhody

Kdy se používá: CT vyšetření provedená v iktovém protokolu pro akutní fokální neurologický deficit.

Technika: Nativní CT mozku; doplněno hodnocení v iktovém okně.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [V povodí MCA/v inzulární kůře/v nucleus lentiformis] střední rozhraní šedé a bílé hmoty a mírná hypodenzita; střední sousedních sulků. Intrakraniální krvácení nebylo zjištěno.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [MCA] v povodí ... známky časné akutní ischémie; bez intrakraniálního krvácení. V rámci iktového protokolu klinickému týmu [hodin] hlášeno.

040 Nativní CT mozku · Příznak hyperdenzní MCA

Kdy se používá: Případy, kdy při podezření na cévní mozkovou příhodu vidíte v MCA zřetelnou hyperdenzitu ve srovnání s druhostrannou.

Technika: Nativní CT mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] MCA [M1/M2] v segmentu ... zřetelná hyperdenzita ve srovnání s druhostrannou (příznak hyperdenzní tepny). Doprovodné časné ischemické změny [není/je]. Krvácení nebylo prokázáno.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] Příznak hyperdenzní arterie v MCA; může svědčit pro akutní trombus. Doporučeno zhodnocení pomocí CT angiografie. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

041 Nativní CT mozku · Hydrocefalus

Kdy se používá: Případy, kdy jsou komory dilatované disproporčně k sulkům.

Technika: Nativní CT mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V postranních komorách a třetí komoře [a ve čtvrté komoře] zřetelná dilatace neúměrná sulkům. Periventrikulární hypodenzita [přítomen/nepřítomen]. Úroveň obstrukce: [výše / nelze spolehlivě diferencovat].

Závěr: [Obstrukční/Komunikující] známky hydrocefalu. V porovnání s předchozím vyšetřením [progrese/beze změn]. Pokud vzniklo akutně, klinickému týmu [hodin] hlášeno.

042 CT mozku · Expanze a vazogenní edém

Kdy se používá: Případy, kdy při bolesti hlavy, záchvatu nebo fokálním deficitu vidíte lézi s expanzivním chováním.

Technika: Nativní [± i.v. kontrastní látka] CT mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [lalok] v [.. mm] o velikosti [izodenzní/hyperdenzní] ložisková expanze; v okolí prstovitě se šířící vazogenní edém. Expanzivní chování: stření sulků, [útlak ipsilaterální komory], [.. mm] přesun středočárových struktur.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lalok] ložisková expanze a perifokální vazogenní edém. K bližší charakterizaci se doporučuje MR mozku s kontrastní látkou. Známky herniace [není/je přítomen; nahlášeno klinickému týmu].

043 CT mozku · Fraktura kalvy

Kdy se používá: Případy kraniotraumatu, kde je v kostním okně patrná linie fraktury.

Technika: Nativní CT mozku; kostní okno a 3D rekonstrukce.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [frontální/parietální/temporální/okcipitální] v kosti [lineární / impresivní] lomná linie; míra deprese [.. mm]. Přilehlé extraaxiální krvácení [není/je]. Pneumocefalus [není/je]. Hematom ve kštici.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [kost] [lineární / impresivní] fraktura. Doprovodné intrakraniální krvácení [nepřítomno/...].

044 CT plicní angiografie · Plicní embolie

Kdy se používá: Případy s defektem v náplni na CT angiografii plicnice provedené pro podezření na PE. Akutní hlášení.

Technika: CT plicní angiografie. Opacifikace plicnice [dostatečná/nedostatečná].

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo/Bilaterálně] [hlavní/lobární/segmentální/subsegmentální] defekty v náplni v plicních tepnách. Poměr pravé komory k levé komoře [zvýšený/normální]; v interventrikulárním septu [oploštění / vyklenutí doleva] [přítomen/nepřítomen]. Klínovitá konsolidace na periferii [není/je přítomen; může odpovídat infarktu].

Závěr: [Bilaterálně] akutní plicní embolie. Známení přetížení pravé komory [přítomen/nepřítomen]. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

045 CT hrudníku · Incidentální plicní uzel

Kdy se používá: Případy, kdy na CT provedeném z jiné indikace zachytíte náhodný nodul.

Technika: [S IV kontrastem/Nativně] CT hrudníku, tenké řezy.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [lalok] [segment] v [.. mm] o velikosti [solidní / subsolidní / charakteru mléčného skla] nodulus; [hladký/laločnatý/spikuliformní] ohraničený. Kalcifikace [není/je].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lalok] v [.. mm] [solidní] uzel. Nutnost a interval sledování by měly být stanoveny ve spolupráci s klinickým týmem podle rizikového profilu pacienta a platných doporučených postupů vašeho pracoviště.

046 CT hrudníku · Emfyzém

Kdy se používá: Případy, kdy u kuřáka nebo pacienta s CHOPN vidíte okrsky emfyzému.

Technika: Nativní CT hrudníku; plicní okno.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bilaterálně [s predominancí v horních lalocích] [centrilobulární / paraseptální / panlobulární] oblasti emfyzému. [Buly.] Konsolidace ani ložisková léze nezastiženy.

Závěr: [Centrilobulární] emfyzém. Bez známek akutní parenchymové patologie.

047 CT hrudníku · Zastření charakteru mléčného skla

Kdy se používá: Případy s dušností, horečkou nebo hypoxémií a nálezem oblastí mléčného skla.

Technika: [Nativně/s IV kontrastem] CT hrudníku; plicní okno.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bilaterálně [periferní / centrální / difuzní], [s predilekcí v dolních lalocích] denzity mléčného skla. Ztluštění interlobulárních sept [přítomno (vzhled dlažebních kostek) / nepřítomno]. Pleurální výpotek [není/je].

Závěr: Oboustranné zastření charakteru mléčného skla. V diferenciální diagnóze přicházejí v úvahu virové a atypické infekce, plicní edém, alveolární hemoragie a další zánětlivé procesy; doporučena klinická a laboratorní korelace.

048 CT hrudníku · Pneumotorax

Kdy se používá: Případy po úrazu nebo intervenci, kdy na CT vidíte vzduch v pleurální dutině.

Technika: CT hrudníku; plicní okno.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v hemitoraxu [anteriorní/apikální/difúzní] lokalizovaný, v nejsilnějším místě [.. mm] pneumotorax. Přesun mediastina [není/je]. Pneumomediastinum [není/je]. Podkožní emfyzém [není/je]. Fraktury žeber [není/je].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [malý/střední/velký] pneumotorax. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

049 CT angiografie · Disekce aorty

Kdy se používá: Případy, kdy při náhle vzniklé bolesti na hrudi nebo v zádech vidíte intimální flap. Urgentní hlášení.

Technika: Nativní vyšetření a arteriální fáze CT angiografie.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Z ascendentní aorty/distálně od levé arteria subclavia] začínající [výše] sahající intimální flap; je patrné pravé a nepravé lumen. Disekce [do větví oblouku/truncus coeliacus/SMA/renálních arterií] propagace: [detail]. Perikardiální výpotek [není/je]. Mediastinální hematom [není/je].

Závěr: [Postihující ascendentní aortu (Stanford A)/nepostihující ascendentní aortu (Stanford B)] disekce aorty. Urgentní nález; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

050 CT břicha · Aneuryzma břišní aorty

Kdy se používá: Případy s bolestmi břicha či zad nebo s náhodně zjištěnou dilatací aorty.

Technika: [CT angiografie s kontrastem/CT břicha v portální venózní fázi].

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V infrarenální břišní aortě maximální [.. mm] o průměru [fuziformní/sakulární] aneuryzmatické rozšíření; kalcifikace stěny a [nástěnný trombus]. Vzdálenost od renálních tepen [.. mm]. Periaortální hematom nebo prosáknutí tukové tkáně [nepřítomno/přítomno].

Závěr: Aneuryzma infrarenální břišní aorty, maximální průměr [.. mm]. Nález svědčící pro rupturu [nepřítomno/přítomno]. Při známkách ruptury jako urgentní nález klinickému týmu [hodin] hlášeno.

051 CT břicha · Akutní apendicitida

Kdy se používá: Případy s nálezem zaníceného apendixu při bolesti v pravém dolním kvadrantu.

Technika: CT břicha a pánve s i.v. kontrastní látkou, portovenózní fáze.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Apendix [.. mm] o průměru ..., se zesílenou stěnou a zvýšeným sycením; prosáknutí okolního tuku. Apendikolit [přítomen/nepřítomen]. Periapendikulární tekutina, absces nebo volný vzduch [není/je].

Závěr: Nález svědčící pro akutní apendicitidu. Nález svědčící pro perforaci nebo absces [nepřítomno/přítomno]. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

052 CT břicha · Akutní divertikulitida

Kdy se používá: Případy s bolestí v levém dolním kvadrantu, kdy vidíte zánět v segmentu s divertikly.

Technika: CT břicha a pánve s i.v. kontrastní látkou.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Sigmoideum/Descendens] divertikly v tračníku; [.. cm] zesílení stěny v segmentu délky ... a prosáknutí perikolického tuku. Perikolický volný plyn [není/je]. Absces [není/je přítomen, .. mm].

Závěr: [Sigmoideum] akutní v tračníku [nekomplikovaný/komplikovaný] divertikulitida. Vyšetření tračníku po odeznění akutního stavu se ponechává na klinickém uvážení.

053 CT břicha · Obstrukce tenkého střeva

Kdy se používá: Případy s podezřením na obstrukci na RTG nebo přicházející se zvracením a distenzí.

Technika: CT břicha a pánve s i.v. kontrastní látkou.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Dilatované kličky tenkého střeva a distálněji kolabované kličky; přechodová zóna [pravý dolní kvadrant / pánev / ...]. Pravděpodobná příčina: [adheze/hernie/expanze/nelze jednoznačně diferencovat]. Snížení sycení střevní stěny, mezenteriální edém a volná tekutina [není/je]. Pneumatóza [není/je].

Závěr: [Oblast] mechanická obstrukce tenkého střeva s tranzitní zónou v ...; pravděpodobná příčina [příčina]. Nález svědčící pro ischemii [nepřítomno/přítomno]. Při známkách ischémie jako urgentní nález klinickému týmu [hodin] hlášeno.

054 CT břicha · Pneumoperitoneum (perforace)

Kdy se používá: Případy, kdy u akutního břicha vidíte na CT volný vzduch. Urgentní hlášení.

Technika: CT břicha a pánve s i.v. kontrastní látkou; doplňující hodnocení v plicním okně.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Před játry/periportálně/v mezenteriu] volný vzduch. Volná tekutina [není/je]. Pravděpodobné místo perforace: [žaludek / duodenum / kolon]; [defekt stěny / ložiskové zesílení stěny / okolní zánětlivé změny].

Závěr: Pneumoperitoneum; [možná lokalizace] svědčí pro perforaci. Akutní nález; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

055 Nativní CT · Ureterolitiáza

Kdy se používá: Nativní CT se zaměřením na urolitiázu (stone protokol) při podezření na renální koliku.

Technika: Nativní CT břicha a pánve (protokol na litiázu).

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] ureter [v proximální / střední / distální části / v ureterovezikální junkci] [.. mm] konkrement. V proximálním ureteru a kalichopánvičkovém systému [mírný/střední/výrazný] dilatace; prosáknutí perirenálního tuku. V kontralaterální ledvině [bez konkramentu / ..mm konkrament].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [distální] v ureteru [.. mm] konkrement a [mírný] hydroureteronefróza.

056 CT břicha · Akutní pankreatitida

Kdy se používá: Případy s klinickým a laboratorním podezřením na pankreatitidu, kde je požadováno zhodnocení komplikací.

Technika: CT břicha s i.v. kontrastní látkou, [pankreatická fáze a] portální venózní fáze.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Pankreas [difúzní/fokální] edematózní; prosáknutí peripankreatického tuku a tekutina. V parenchymu nesytící se okrsek [není/je]. Cholecystolitiáza [přítomen/nepřítomen]. Splenická a portální žíla [průchodný/suspektní trombus].

Závěr: Akutní [intersticiální edematózní / nekrotizující] známky pankreatitidy. Komplikace: [není/...].

057 CT břicha · Mnohočetná ložiska v játrech svědčící pro metastázy

Kdy se používá: Případy onkologických pacientů nebo kdy poprvé zachytíte mnohočetné léze v játrech.

Technika: CT břicha s i.v. kontrastní látkou, portovenózní fáze.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V obou lalocích jater, největší v segmentu [..]: [.. mm] o velikosti ..., mnohočetné hypodenzní léze s periferním sycením.

Závěr: Mnohočetná ložiska v játrech, která mohou odpovídat metastázám. Oproti předchozímu vyšetření [nový/progredující/stacionární]. Doporučuje se klinická a v případě potřeby histopatologická korelace.

058 Trauma CT · Poranění sleziny

Kdy se používá: Případy s lacerací nebo hematomem sleziny při tupém traumatu břicha. Urgentní hlášení.

Technika: Trauma CT s i.v. kontrastní látkou, arteriální a portovenózní fáze.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Ve slezině [.. mm] lacerace v délce ... / subkapsulární hematom. Perisplenicky a [pánevní] volná tekutina (odpovídající hemoperitoneu). Aktivní extravazace kontrastní látky [není/je].

Závěr: Poranění sleziny ([lacerace/hematom]) a hemoperitoneum. Známky aktivního krvácení [není/je]. Klasifikace se provádí podle systému používaného na vašem pracovišti. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

059 CT břicha · Prostá jaterní cysta

Kdy se používá: Náhodné, typicky vyhlížející cystické léze jater.

Technika: CT břicha s i.v. kontrastní látkou.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Segment jater [..]: [.. mm] o velikosti ..., ostře ohraničená léze tekutinové denzity, s tenkou stěnou, bez sycení.

Závěr: Segment jater [..]: léze odpovídající prosté cystě.

060 CT břicha · Akutní cholecystitida

Kdy se používá: Případy s nálezem zánětu žlučníku na CT při bolesti v pravém horním kvadrantu.

Technika: CT břicha s i.v. kontrastní látkou.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Žlučník je distendovaný, se zesílenou stěnou; pericholecystická tekutina a prosáknutí okolního tuku. V lumen [konkrament je diferencovatelný / konkrament není diferencovatelný]. Plyn ve stěně, vymizení sycení nebo perforace [není/je].

Závěr: Nález svědčící pro akutní cholecystitidu. Senzitivita CT pro žlučové kameny je omezená; doporučena korelace s UZ.

061 CT páteře · Akutní fraktura obratle

Kdy se používá: Případy po úrazu s bolestí zad nebo beder, kdy vidíte frakturu těla obratle.

Technika: Nativní [torakolumbální] CT; sagitální a koronální rekonstrukce.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [L1] v těle obratle [kompresivní/tříštivá (burst)] fraktura; snížení přední výšky. Zadní stěna [zachován / zúžení páteřního kanálu retropulzovaným fragmentem]. Zadní elementy [intaktní / fraktura].

Závěr: [L1] akutně vyhlížející v obratli [kompresivní/tříštivá (burst)] fraktura; ve spinálním kanálu [zúžení přítomno/nepřítomno]. Při přítomnosti neurologického nálezu se doporučuje MR.

062 CT vedlejších nosních dutin · Sinusitida

Kdy se používá: CT vedlejších dutin nosních indikované pro chronickou nebo recidivující sinusitidu.

Technika: Nativní CT paranazálních dutin; koronární rekonstrukce.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo/Bilaterálně] [maxilární / etmoidální / frontální / sfenoidální] v sinu [slizniční ztluštění / hladinka tekutiny / kompletní zastření]. Osteomeatální jednotka [otevřený/uzavřený]. Kostní destrukce, šíření do očnice ani intrakraniálně nebylo patrné.

Závěr: [Lokalizace] známky sinusitidy. Hladinka tekutiny může odpovídat akutní sinusitidě; doporučena klinická korelace.

063 CT břicha · Incidentální adrenální nodulus

Kdy se používá: Případy, kdy na CT provedeném z jiné indikace náhodně zachytíte uzel v nadledvině.

Technika: [Nativně/s IV kontrastem] CT břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v nadledvině [.. mm] o velikosti ..., ostře ohraničený uzel; [nativní denzita .. HU / při postkontrastním vyšetření nelze charakterizovat].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] nodul nadledviny. Nutnost bližší charakterizace a sledování by měla být stanovena ve spolupráci s klinickým týmem dle platných doporučení; v případě potřeby se doporučuje CT s adrenálním protokolem nebo MR s chemickým posunem (chemical shift).

064 CT hrudníku · Pneumonie (konsolidace)

Kdy se používá: CT indikovaná při nejednoznačném nálezu pneumonie na RTG nebo při podezření na komplikace.

Technika: [Nativně/s IV kontrastem] CT hrudníku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [lalok] konsolidace se vzdušným bronchogramem v ...; v okolí denzity mléčného skla. Pleurální výpotek [není/je]. V mediastinu [reaktivního vzhledu] lymfatické uzliny. Kavitace nebo absces [není/je].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lalok] konsolidace; může odpovídat infekčnímu procesu (pneumonii). Kontrola po léčbě se doporučuje dle klinického uvážení.

065 Trauma CT · Hemoperitoneum

Kdy se používá: Případy se zjištěnou volnou tekutinou při tupém traumatu břicha.

Technika: Trauma CT s i.v. kontrastní látkou.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Morisonovo pole/perisplenická oblast/pánev] volná tekutina v ...; denzita [.. HU], odpovídající hemoperitoneu. Poranění parenchymatózních orgánů [nepřítomno/...]. Ve střevní stěně a mezenteriu [bez patologie / ...].

Závěr: [Malé/Střední/Velké množství] množství hemoperitonea. Při absenci poranění parenchymatózních orgánů se doporučuje klinické sledování k vyloučení poranění střeva nebo mezenteria. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

ČÁST 3

MR

25 šablon: 3 normální, 22 častých nálezů v rutině a ve službě.

066 MR mozku · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: MR mozku bez průkazu patologie při došetřování bolesti hlavy, vertiga nebo záchvatu.

Technika: MR mozku; axiální T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI/T2*], [postkontrastní T1] sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V mozkovém parenchymu nezastižena signálová abnormalita. Na DWI bez restrikce difuze. Komorový systém a sulky odpovídají věku. Středočárové struktury bez deviace.
[Po aplikaci kontrastní látky bez patologického sycení.] V hlavních tepnách jsou patrné proudové fenomény (flow voids).

Závěr: Na MR mozku nebyla zjištěna žádná významná patologie.

067 MR bederní páteře · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy bolesti zad bez patrné patologie disku, nervového kořene nebo páteřního kanálu.

Technika: MR bederní páteře; sagitální sekvence T1, T2, STIR a axiální sekvence T2.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bederní lordóza je zachována, postavení obratlů je normální. Výšky obratlových těl i signál kostní dřeně jsou obvyklé. Na meziobratlových ploténkách nejsou patrné známky významnější degenerace ani hernie. Páteřní kanál a neurální foramina jsou volné. Conus medullaris je v obvyklé výši i signálu.

Závěr: Na MR bederní páteře nebyla zjištěna žádná významná patologie.

068 MR kolene · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy s bolestí nebo traumatem kolene, kde není patrná strukturální patologie.

Technika: [Vpravo/Vlevo] MR kolena; PD sekvence se saturací tuku, T1 a T2 sekvence, tři roviny.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V meniscích nebyla zachycena zvýšená intenzita signálu svědčící pro rupturu. Přední a zadní zkřížený vaz, kolaterální vazy i extenzorový aparát jsou v normě. Edém kostní dřeně není přítomen. Kloubní chrupavka je zachována. Bez zřetelného kloubního výpotku.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] na MR kolena nebyla zjištěna signifikantní patologie.

069 MR mozku · Akutní infarkt (DWI)

Kdy se používá: Případy, kdy při akutním fokálním deficitu vidíte restrikci difuze. Hlášení.

Technika: MR mozku; sekvence DWI/ADC, FLAIR, T2, SWI/T2*.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [oblast] oblast vykazující difuzní restrikci v ..., hyperintenzní na DWI, hypointenzní na ADC mapě. Na FLAIR [bez patrné signálové změny/lehká hyperintenzita]. Hemoragická transformace [nepřítomno/přítomno].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [tepna] akutní infarkt v povodí ... Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

070 MR mozku · Demyelinizační plaky

Kdy se používá: Případy, kdy zachytíte léze bílé hmoty při optické neuritidě, senzitivním deficitu nebo při sledování RS.

Technika: MR mozku; FLAIR (preferenčně 3D), T2, T1, DWI, postkontrastní T1.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Periventrikulárně, [juxtakortikální], [infratentoriální] lokalizované, ovoidní T2/FLAIR hyperintenzní léze orientované kolmo na corpus callosum. Po podání kontrastní látky [.. sycení v lézi/bez sycení].

Závěr: Léze bílé hmoty, které mohou svědčit pro demyelinizační onemocnění. Ve srovnání s předchozím vyšetřením nová nebo sytící se léze [není/je]. Diagnózu je třeba hodnotit ve spojení s klinickými nálezy a aktuálními diagnostickými kritérii.

071 MR mozku · Prstencovitě se sytící intraaxiální expanze

Kdy se používá: Parenchymové léze sytící se po podání kontrastní látky, s expanzivním chováním a edémem.

Technika: Kontrastní MR mozku; DWI, [perfuze], sekvence SWI.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [lalok] v [.. mm] o velikosti ..., nepravidelně prstencovitě se sytící masa s centrální nekrózou; v okolí vazogenní edém a expanzivní chování. Propagace do corpus callosum [není/je]. Výrazná restrikce difuze v centrální části [není/je].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [lalok] prstencovitě se sytící intraaxiální expanze; v diferenciální diagnostice je třeba pomýšlet především na high-grade gliový tumor a metastázu. Při výrazné centrální difuzní restrikci je nutno zvážit absces.

072 MR mozku · Meningiom

Kdy se používá: Extraaxiální expanze se širokým durálním nasedáním a homogenním sycením.

Technika: Kontrastní MR mozku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Oblast] se širokou durální bází v ..., [.. mm] o velikosti ..., na T1 izointenzní, homogenně se sytící extraaxiální masa; příznak durálního ocasu. Edém v sousedním parenchymu [není/je]. Masový efekt [není/je].

Závěr: [Oblast] extraaxiální masa odpovídající meningeomu v ...

073 MR hypofýzy · Adenom hypofýzy

Kdy se používá: MR hypofýzy indikovaná pro hormonální poruchu nebo výpadek zorného pole.

Technika: MR hypofýzy; tenkořezné koronální a sagitální T1, T2 a dynamické postkontrastní sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V hypofýze [.. mm] o velikosti ..., léze s pozdnějším sycením oproti normální žláze v dynamických sériích. Supraselární propagace [není/je]; útlak chiazma opticum [není/je]. Invaze do kavernózního splavu [suspektní/nepřítomen]. Stopka hypofýzy [ve střední čáře / deviován].

Závěr: Hypofýza [mikro / makro]léze kompatibilní s adenomem. Doporučena endokrinologická korelace.

074 MR mozku · Mozkový absces

Kdy se používá: Případy, kdy při horečce a fokálním deficitu vidíte hladce ohraničenou prstencovitě se sytící lézi. Hlášení.

Technika: Kontrastní MR mozku; včetně DWI/ADC.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Lokalizace] v [.. mm] o velikosti ..., tence a hladce prstencovitě se sytící léze; její obsah vykazuje výraznou difuzní restrikci na DWI. Periferní vazogenní edém.

Závěr: Nález svědčící pro mozkový absces. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

075 MR mozku a MR venografie · Trombóza žilních splavů

Kdy se používá: Pacienti přicházející s bolestí hlavy, záchvatem nebo edémem papily, zejména pokud mají rizikové faktory. Hlášení.

Technika: MR mozku a nativní/kontrastní MR venografie.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Sinus sagittalis superior/transversus/sigmoideus] v sinu ztráta normálního flow void fenoménu a signál svědčící pro trombus; na MR venografii defekt v náplni / vymizení toku. V sousedním parenchymu venózní infarkt nebo hemoragie [není/je].

Závěr: [Sinus] trombóza. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

076 MR mozku · Chronická mikroangiopatie

Kdy se používá: Nespecifické léze bílé hmoty u starších pacientů nebo pacientů s vaskulárními rizikovými faktory.

Technika: MR mozku; sekvence FLAIR, T2, DWI.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bilaterálně v periventrikulární a hluboké bílé hmotě punktiformní a místy splývající T2/FLAIR hyperintenzity. Na DWI bez restrikce difuze. [Chronické lakunární infarkty.]

Závěr: Změny bílé hmoty slučitelné s chronickým onemocněním malých cév. Akutní infarkt nezastižen.

077 MR bederní páteře · Hernie disku

Kdy se používá: MR bederní páteře indikované pro bolesti zad a dolních končetin (radikulopatii).

Technika: MR bederní páteře; sagitální sekvence T1, T2 a axiální sekvence T2.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: L [4-5] ztráta T2 signálu a snížení výšky disku; [vpravo / vlevo] [paramediální / foraminální] [protruze / extruze] ve smyslu herniace. [Vpravo/Vlevo] [L5] v nervovém kořeni [kontakt/útlak]. Páteřní kanál [průchodný/zúžený]. Neuroforamina [průchodný/zúžený].

Závěr: L [4-5] [vpravo paramediálně] disk [extruze]; [L5] na nervový kořen [útlak].

078 MR krční páteře · Disk-osteofytový komplex

Kdy se používá: MR krční páteře indikované pro bolesti krku a horní končetiny nebo parestezie.

Technika: MR krční páteře; sagitální T1, T2, STIR a axiální T2 sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: C [5-6] v úrovni [vpravo / vlevo] [paramediální / foraminální] komplex disk-osteofyt; [vpravo / vlevo] zúžení neurálního foramina. Signál míchy [obvyklý / v T2 hyperintenzní].

Závěr: C [5-6] komplex disk-osteofyt a [vpravo] foraminální zúžení. Změna signálu v míše [není/je přítomen; může odpovídat myelopatii].

079 MR hrudní páteře · Epidurální útlak a útlak míchy

Kdy se používá: Bolesti zad nebo nově vzniklý neurologický deficit u pacienta se známou malignitou. Urgentní hlášení.

Technika: Kontrastní hrudní [a celé páteře] MR.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: T [..] v obratli T1 hypointenzní, sytící se léze kostní dřeně; s epidurálním šířením způsobujícím zúžení páteřního kanálu a kompresi míchy. V míše zvýšení T2 signálu [není/je]. V ostatních úrovních [bez dalších lézí / další léze].

Závěr: T [..] v úrovni léze kompatibilní s epidurálním šířením tumoru a útlakem míchy. Urgentní nález; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

080 MR bederní páteře · Akutní kompresivní fraktura

Kdy se používá: Případy, kdy při mírném traumatu nebo při bolesti zad bez traumatu zachytíte ztrátu výšky těla obratle.

Technika: MR bederní páteře; sagitální sekvence T1, T2, STIR.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [L1] ztráta výšky těla; na STIR edém kostní dřeně. Retropulze zadní hrany [není/je]. Postižení zadních elementů, epidurální nebo paravertebrální expanze měkkých tkání [nepřítomno/přítomno].

Závěr: [L1] v obratli [akutní/subakutní] kompresivní fraktura. Známky patologické fraktury [nepřítomno/přítomno; doporučeno další došetření].

081 MR kolene · Ruptura předního zkříženého vazu

Kdy se používá: Případy pacientů přicházejících s nestabilitou a výpotkem po pivotním traumatu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] MR kolena; PD sekvence se saturací tuku a T1 sekvence, tři roviny.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: na ACL [proximální / střední část] přerušení kontinuity a ztráta normálního lineárního průběhu. Kostní kontuze laterálního kondylu femuru a posterolaterálního tibiálního plató [přítomen/nepřítomen]. Kloubní výpotek.

Závěr: [Transmurální (kompletní)/Parciální] Ruptura ACL. Doprovodná [meniskus / kolaterální vaz] patologie [není/je].

082 MR kolene · Léze menisku

Kdy se používá: MR kolene indikované pro blokády, bolest v kloubní štěrbině nebo po úrazu.

Technika: [Vpravo/Vlevo] MR kolena; PD sekvence se saturací tuku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Mediální/Laterální] meniskus [zadní roh/tělo/přední roh] v části zasahující ke kloubnímu povrchu [horizontální/šikmý/radiální/longitudinální] zvýšení signálu.
[Dislokovaný meniskeální fragment (typu ucha od košíku) nezastižen/zastižen.]

Závěr: [Mediální] meniskus [zadní roh] [šikmá] ruptura.

083 MR kolene · Kostní kontuze

Kdy se používá: Případy po úrazu s normálním RTG snímkem, kde na MR vidíte edém kostní dřeně.

Technika: [Vpravo/Vlevo] MR kolena; PD sekvence se saturací tuku a T1 sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Laterální kondyl femuru/tibiální plato], bez zřetelné lomné linie edém kostní dřeně v sekvencích se saturací tuku. Na T1 lineární hypointenzní lomná linie [není/je].

Závěr: [Oblast] kostní kontuze v ...; [lomná linie nezobrazena / subchondrální lomná linie patrná].

084 MR ramene · Ruptura rotátorové manžety

Kdy se používá: MR ramene indikované pro bolest ramene a slabost při abdukci.

Technika: [Vpravo/Vlevo] MR ramene; PD/T2 se saturací tuku a T1 sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Šlachy m. supraspinatus [anteriorní] v oblasti [kloubní plocha / burzální plocha parciální / transmurální] ruptura; retrakce [.. mm]. Ve svalu atrofie nebo tuková degenerace [není/je]. Tekutina v subakromiálně-subdeltoidální burze.

Závěr: Ve šlaše m. supraspinatus [totální / parciální] ruptura; retrakce [.. mm].

085 MR kyčle · Avaskulární nekróza hlavice femuru

Kdy se používá: Pacienti s bolestí kyčle, užíváním kortikosteroidů nebo jinými rizikovými faktory.

Technika: MR obou kyčlí; koronální T1, STIR a axiální sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] subchondrálně v hlavici femuru mapovité ložisko lemované na T1 hypointenzní linií; na T2 příznak dvojí linie. Kolaps kloubního povrchu [není/je]. Kloubní výpotek [není/je]. Kontralaterální hlavice femuru [obvyklý / obdobné změny].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] avaskulární nekróza hlavice femuru; kolaps kloubního povrchu [nepřítomno/přítomno].

086 MR jater · Hemangiom

Kdy se používá: Charakterizace nejasné jaterní léze z UZ nebo CT.

Technika: Dynamická postkontrastní MR jater; T2, DWI a arteriální, portovenózní a pozdní fáze.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Segment jater [..]: [.. mm], léze výrazně hyperintenzní na T2, v dynamických sériích vykazující periferní nodulární a centripetálně progredující sycení.

Závěr: Segment jater [..]: léze odpovídající typickému hemangiomu.

087 MRCP · Choledocholitiáza

Kdy se používá: Zhodnocení žlučových cest u pacienta se známkami cholestázy nebo s cholelitiázou.

Technika: MRCP; silně T2-vážené 2D a 3D sekvence.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V distálním choledochu [.. mm] o velikosti ..., defekt náplně tvořící signálový výpadek na T2. Choledochus [.. mm] o průměru ..., v intrahepatických žlučovodech [mírný] dilatace. Ve žlučníku [konkramenty].

Závěr: Konkrament v distálním choledochu (choledocholitiáza) a dilatace žlučových cest. Při klinickém podezření na cholangitidu klinickému týmu [hodin] hlášeno.

088 MR bederní páteře · Spondylodiscitida

Kdy se používá: MR vyšetření s kontrastem provedená pro horečku, elevaci zánětlivých markerů a bolesti beder.

Technika: Kontrastní MR bederní páteře; T1, T2, STIR a postkontrastní T1 s potlačením tuku.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: L [..] T2 hyperintenzita a sycení v disku; eroze a edém kostní dřeně v sousedních krycích plochách. [Paravertebrální/epidurální] [flegmóna/absces] [není/je].

Závěr: L [..] známky spondylodiscitidy; epidurální absces [není/je]. V případě epidurálního abscesu klinickému týmu [hodin] hlášeno.

089 MR kolene · Popliteální (Bakerova) cysta

Kdy se používá: Pacienti s otokem nebo bolestí v podkolení.

Technika: [Vpravo/Vlevo] MR kolena.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V popliteální fosse, odstupující mezi šlachami mediální hlavy m. gastrocnemius a m. semimembranosus [.. mm] kolekce tekutiny. Okolní edém svědčící pro rupturu [není/je].

Závěr: Popliteální (Bakerova) cysta; známky ruptury [není/je].

090 MR pánve · Prostá adnexální cysta

Kdy se používá: Charakterizace adnexální cystické léze zachycené na UZ.

Technika: Kontrastní MR pánve; T1, T1 s potlačením tuku, T2, DWI.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] na ovariu [.. mm] o velikosti ..., tenkostěnná a hladce ohraničená, na T2 homogenně hyperintenzní cystická léze bez solidní složky či sytících se sept.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] na ovariu léze odpovídající prosté cystě. Nutnost sledování by měl určit klinický tým podle věku pacientky a stavu menopauzy.

ČÁST 4

UZ a Doppler

30 šablon: 5 normálních, 25 častých nálezů ve službě a v rutině (včetně POCUS a eFAST).

091 UZ celého břicha · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: UZ břicha bez patologického nálezu u pacientů s bolestmi břicha nebo v rámci rutinní kontroly.

Technika: UZ celého břicha; [nalačno].

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Játra normální velikosti a echogenity, bez ložiskových změn. Žlučník s normální stěnou, lumen anechogenní; konkrement nepozorován. Intrahepatické ani extrahepatické žlučovody nejsou dilatované. Pankreas [přehlédnutelné úseky] v normě. Slezina normální velikosti. Obě ledviny normální velikosti a echogenity parenchymu; kalichopánvičkový systém nedilatován. Močový měchýř [naplněný, stěna normální]. V břišní dutině nebyla prokázána volná tekutina.

Závěr: Na UZ celého břicha nebyla zjištěna patologie.

092 UZ močového traktu · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy s bolestí v boku, infekcí močových cest nebo renální dysfunkcí, kde nevidíte patologii.

Technika: UZ močového traktu.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Obě ledviny normální velikosti, uložení a šíře parenchymu; kortikomedulární diferenciace zachována. Kalichopánvičkový systém bez dilatace. Konkrement ani expanze nepozorovány. Močový měchýř [naplněný, stěna normální, lumen anechogenní].

Závěr: Při UZ močového traktu nebyla zjištěna žádná patologie.

093 UZ štítné žlázy · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Případy s podezřením na poruchu funkce štítné žlázy nebo hmatnou rezistenci, kdy nevidíte patologii.

Technika: UZ štítné žlázy a krku; vysokofrekvenční lineární sonda.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Štítná žláza je normální velikosti a homogenní echogenity parenchymu. Uzly nezastiženy. Vaskularizace v barevném Doppleru je v normě. Na krku nebyly zjištěny patologicky vyhlížející lymfatické uzliny.

Závěr: Na UZ štítné žlázy nebyla zjištěna patologie.

094 Venózní Doppler dolních končetin · Normální nález

NORMÁLNÍ

Kdy se používá: Vyšetření žilním Dopplerem při podezření na DVT bez nálezu trombózy.

Technika: [Vpravo/Vlevo] venózní Doppler UZ dolních končetin; B-mód komprese, barevný a spektrální Doppler.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Společná femorální, femorální a popliteální žíla jsou plně kompresibilní; v jejich lumen nebyl zjištěn trombus. V barevném dopplerovském zobrazení je náplň lumen kompletní, ve spektrálním vyšetření je přítomna respirační variabilita a odpověď na augmentaci. [Bércové žíly byly/nebyly hodnoceny].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] dolní končetina [v hlubokých žilách] trombóza nebyla prokázána.

095 eFAST · Negativní

Kdy se používá: Případy traumatického pacienta, kdy při bedside vyšetření eFAST nevidíte volnou tekutinu ani pneumotorax.

Technika: Lůžkový eFAST.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V Morisonově prostoru, splenorenální krajině a v pánvi nebyla zachycena volná tekutina. Při subxifoidálním zobrazení bez perikardiálního výpotku. Oboustranně přítomen fenomén klouzání plíce (lung sliding).

Závěr: Při eFAST nebyla zjištěna volná tekutina, perikardiální výpotek ani známky pneumotoraxu. Negativní eFAST nevylučuje poranění orgánů; dle klinického stavu se doporučuje CT.

096 UZ břicha · Cholelitiáza

Kdy se používá: Případy, kdy ve žlučníku zachytíte echogenní fokus vrhající akustický stín.

Technika: UZ břicha; nalačno.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V lumen žlučníku, největší z nich [.. mm] o velikosti ..., polohově pohyblivá echogenní ložiska vrhající dorzální akustický stín. Tloušťka stěny [obvyklý / zvýšený]. Pericholecystická tekutina [není/je]. Sonografické Murphyho znamení [negativní / pozitivní]. Choledochus [.. mm].

Závěr: Cholecystolitiáza. Nález svědčící pro akutní cholecystitidu [nepřítomno/přítomno].

097 UZ břicha · Akutní cholecystitida

Kdy se používá: Případy s bolestí v pravém horním kvadrantu, horečkou a pozitivním sonografickým Murphyho příznakem.

Technika: UZ břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Žlučník je distendovaný, se zesílenou stěnou [a edematózní, dvojitá kontura]; v oblasti krku [.. mm] konkrement. Pericholecystická tekutina [přítomen]. Sonografické Murphyho znamení pozitivní.

Závěr: Nález svědčící pro akutní kalkulózní cholecystitidu. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

098 UZ močového traktu · Hydronefróza

Kdy se používá: Případy s bolestí v boku, renální kolikou nebo renální dysfunkcí, kde vidíte dilataci kalichopánvičkového systému.

Technika: UZ močového traktu.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v ledvině [mírný/střední/výrazný] pelvikalikální dilatace; proximální ureter [dilatovaný/nezobrazen]. Tloušťka parenchymu [zachován/ztenčen]. Jako příčina obstrukce [v ureterovezikální junkci .. mm konkrement/jednoznačná příčina nezastižena]. Močový měchýř [..].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [mírný/střední/výrazný] hydronefróza; [možná příčina]. Pokud není příčina jasná, doporučuje se korelace s nekontrastním CT.

099 FAST · Volná tekutina v Morisonově prostoru

Kdy se používá: Případy traumatického pacienta, kdy při vyšetření FAST vidíte volnou tekutinu. Urgentní hlášení.

Technika: Lůžkový FAST.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V Morisonově prostoru [a ve splenorenální krajině/pánvi] anechogenní volná tekutina. Perikardiální výpotek [není/je].

Závěr: FAST pozitivní: [V Morisonově poli] volná tekutina. Urgentní klinické zhodnocení dle hemodynamického stavu; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

100 UZ hrudníku · Pleurální výpotek

Kdy se používá: Podezření na výpotek na RTG nebo určení množství a lokalizace před torakocentézou.

Technika: UZ hrudníku; [vsedě], interkostální skenování.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo/Bilaterálně] v pleurální dutině [anechogenní/s echogenním obsahem/septovaný] tekutina; v nejhlubším místě [.. mm]. Kompresivní atelektáza v přilehlé plíci. [Bez známek pleurální nodularity.]

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [anechogenní/komplikovaného vzhledu] pleurální výpotek. [Vhodné okno pro torakocentézu označeno.]

101 UZ plic · B-linie

Kdy se používá: Případy pacientů s dušností, u kterých jsou na bedside UZ plic patrné B-linie.

Technika: Lůžkový UZ plic; bilaterální zónové vyšetření.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Bilaterálně [anteriorní a laterální] v oblastech, v každém poli mnohočetné B-linie. Pleurální linie [hladký/nepravidelný a zesílený]. Pleurální výpotek [není/je].

Závěr: Oboustranně mnohočetné B-linie; obraz kompatibilní s intersticiálním syndromem. Spolu s hladkou pleurální linií může svědčit pro kardiogenní plicní edém; doporučena klinická a echokardiografická korelace.

102 Venózní Doppler · Hluboká žilní trombóza

Kdy se používá: Případy, kdy u pacienta přicházejícího s otokem a bolestí dolní končetiny vidíte žílu nekomprimovatelnou kompresí. Hlášení.

Technika: [Vpravo/Vlevo] venózní Doppler UZ dolních končetin.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Společná femorální/femorální/popliteální] v žíle při kompresi nekomprimovatelné, lumen [částečně/zcela] echogenní trombus vyplňující ...; na barevném Doppleru [bez toku/parciální tok]. Trombus [proximální hranice: ..].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [femoropopliteální] v segmentu ... nález svědčící pro akutní hlubokou žilní trombózu. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

103 UZ pravého dolního kvadrantu · Akutní apendicitida

Kdy se používá: Případy, kdy u dítěte, mladého pacienta nebo těhotné pacientky s bolestí v pravém podbřišku vidíte zanícený apendix.

Technika: UZ pravého dolního kvadrantu; technika stupňované komprese.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V pravém dolním kvadrantu, při kompresi nekomprimovatelný, [.. mm] slepě zakončená tubulární struktura o průměru ... (apendix); ve stěně zvýšená vaskularizace na barevném Doppleru. Zvýšená echogenita okolního tuku. Apendikolit [přítomen/nepřítomen]. Periapendikulární tekutina [není/je].

Závěr: Nález svědčící pro akutní apendicitidu. Klinickému týmu [hodin] hlášeno. / Apendix nebyl zobrazen; tato skutečnost nevylučuje apendicitidu.

104 UZ břišní aorty · Aneuryzma

Kdy se používá: Případy screeningu, pulzující rezistence nebo bolesti břicha a zad, kdy vidíte dilataci aorty.

Technika: UZ břišní aorty; transverzální a longitudinální měření.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V infrarenální břišní aortě maximální [.. mm] aneuryzmatické rozšíření o průměru ...; v lumen [nástěnný trombus]. Periaortální tekutina [nepřítomno/přítomno].

Závěr: Aneuryzma infrarenální břišní aorty, maximální průměr [.. mm]. U symptomatického pacienta nelze rupturu vyloučit pomocí UZ; klinickému týmu [hodin] hlášeno a doporučena CT angiografie.

105 UZ štítné žlázy · Uzel štítné žlázy

Kdy se používá: Hmatný uzel nebo náhodně zachycený tyreoidální uzel.

Technika: UZ štítné žlázy; lineární sonda, barevný Doppler.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Štítná žláza [vpravo / vlevo] lalok [horní/střední/dolní] v oblasti [.. × .. × .. mm] o velikosti, [solidní / cystický / smíšený], [hypoechogenní/izoechogenní/hyperechogenní], [hladký/nepravidelný] ohraničený nodulus. Mikrokalcifikace [není/je]. [Vertikální orientace dlouhé osy nepřítomna/přítomna]. Patologická lymfatická uzlina na krku [není/je].

Závěr: Štítná žláza [pravý lalok] v [.. mm] nodulus; podle stratifikace rizika používané na vašem pracovišti [kategorie]. Nutnost tenkojehlové aspirační biopsie a sledování by měla být stanovena podle této klasifikace.

106 UZ břicha · Steatóza jater

Kdy se používá: Případy s difuzně zvýšenou echogenitou jaterního parenchymu.

Technika: UZ břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Játra [normální velikosti / zvětšený]; echogenita parenchymu je difuzně zvýšená ve srovnání s kůrou ledviny; stěny portální žíly a bránice [diferencovatelný / nediferencovatelný]. Fokální léze nebyla patrná.

Závěr: [Mírná/Střední/Výrazná] obraz kompatibilní se steatózou jater.

107 UZ pánve · Podezření na ektopickou graviditu

Kdy se používá: Případy s pozitivním těhotenským testem, kde není patrné intrauterinní těhotenství. Hlášení.

Technika: Transabdominální [a transvaginální] pánevní UZ.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V děložní dutině nebyl zastižen gestační váček. [Vpravo/Vlevo] v adnexální oblasti odděleně od ovaria [.. mm] heterogenní expanze [/uvnitř žloutkový váček nebo embryo]. V Douglasově prostoru [s echogenním obsahem] volná tekutina [přítomen/nepřítomen].

Závěr: Intrauterinní těhotenství nezastiženo; [vpravo / vlevo] adnexální expanze a [volná tekutina] spolu se známkami svědčícími pro ektopickou graviditu. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

108 Echokardiografické okno / POCUS · Perikardiální výpotek

Kdy se používá: Případy s dušností, hypotenzí nebo traumatem s nálezem perikardiálního výpotku při subxifoidálním zobrazení.

Technika: Lůžkový subxifoidální [a parasternálně] zobrazení.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V perikardiálním prostoru [cirkulární/lokalizovaný] anechogenní tekutina; v nejširším místě [.. mm]. Diastolický kolaps pravé síně / pravé komory [nepřítomno/přítomno].

Závěr: [Malé/Střední/Velké množství] perikardiální výpotek. Známky svědčící pro tamponádu [není/je přítomen; nahlášeno jako urgentní nález]. K podrobnému zhodnocení se doporučuje echokardiografie.

109 UZ močového traktu · Prostá renální cysta

Kdy se používá: Náhodné, anechogenní léze ledvin.

Technika: UZ močového traktu.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] ledvina [horní/střední/dolní] v ... pólu [.. mm] o velikosti ..., tenkostěnná, anechogenní cysta s dorzálním akustickým zesílením, bez sept či solidní složky.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] léze v ledvině odpovídající prosté kortikální cystě.

110 UZ břicha · Jaterní absces

Kdy se používá: Případy, kdy při horečce a bolesti v pravém horním kvadrantu vidíte v játrech komplikovanou cystickou lézi.

Technika: UZ břicha; barevný Doppler.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Segment jater [..]: [.. mm] o velikosti ..., s nepravidelnou stěnou, vnitřními echogenitami a [debris] hypoechogenní/komplexní cystická léze; v okolí [hyperémie].

Závěr: Segment jater [..]: léze, která může odpovídat abscesu. Doporučena klinická a laboratorní korelace; v případě potřeby kontrastní CT. Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

111 Dopplerovský UZ skrota · Podezření na torzi varlete

Kdy se používá: Případy, kdy při náhle vzniklé skrotální bolesti vidíte snížení toku v postiženém varleti. Urgentní hlášení.

Technika: UZ skrota v šedé škále a barevný/spektrální dopplerovský UZ; srovnání s kontralaterálním varletem.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] testis [zvětšený, heterogenní]; intratestikulární průtok v barevném Doppleru [nepřítomno / výrazně sníženo oproti kontralaterální straně]. V semenném provazci [obraz víru (whirl sign)]. Kontralaterální varle je v normě.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] nález svědčící pro torzi varlete. Urgentní nález; klinickému týmu [hodin] hlášeno. Přítomnost toku zcela nevylučuje torzi.

112 UZ břicha · Ascites

Kdy se používá: Hodnocení tekutiny při distenzi břicha nebo před paracentézou.

Technika: UZ břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: V břišní dutině v perihepatické, perisplenické a pánevní oblasti [malé/střední/velké množství] množství [anechogenní/s echogenním obsahem/septovaný] volná tekutina. Kontura jater [hladký/nodulární].

Závěr: [Malé/Střední/Velké množství] množství ascitu. [Vhodné okno pro paracentézu označeno.]

113 UZ prsu · Prostá cysta

Kdy se používá: UZ vyšetření hmatné rezistence nebo léze zjištěné na mamografii.

Technika: UZ prsů oboustranně; lineární sonda.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] v prsu na pozici ... hodin [..] v úrovni, od prsní bradavky [.. cm] ve vzdálenosti, [.. mm] o velikosti ..., oválná, ostře ohraničená, anechogenní léze s dorzálním akustickým zesílením.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] v prsu léze odpovídající prosté cystě; podle klasifikace používané na vašem pracovišti [kategorie].

114 Dopplerovský UZ karotid · Aterosklerotický plát

Kdy se používá: Hodnocení karotid při cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo screeningu vaskulárního rizika.

Technika: Dopplerovské UZ vyšetření karotických a vertebrálních tepen oboustranně.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] [a. carotis communis/bulbus/a. carotis interna] v tepně [kalcifikovaný/hypoechogenní/heterogenní] aterosklerotický plát. Vrcholová systolická rychlost v úrovni plátu [.. cm/s]. Průtok ve vertebrálních tepnách [antegrádní].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [vnitřní karotida] aterosklerotický plát v tepně; stupeň stenózy dle dopplerovských kritérií používaných na vašem pracovišti [stupeň]. Při významné stenóze se doporučuje korelace s CT nebo MR angiografií.

115 UZ břicha · Dilatace choledochu

Kdy se používá: Případy s elevací cholestatických enzymů nebo ikterem a dilatací žlučových cest.

Technika: UZ břicha.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: Choledochus [.. mm] dilatován na průměr ...; intrahepatické žlučovody [dilatovaný/nedilatovaný]. V distálním choledochu [.. mm konkrement/příčinu obstrukce nelze diferencovat; distální úsek nepřehledný pro střevní plyn]. Ve žlučníku [konkrament přítomen / nepřítomen].

Závěr: Dilatace choledochu; [možná příčina]. Pokud nebyla zjištěna příčina, doporučuje se MRCP.

116 UZ močového traktu · Nefrolitiáza

Kdy se používá: Případy s bolestí v boku nebo hematurií, kde v ledvině vidíte ložisko s akustickým stínem.

Technika: UZ močového traktu.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] ledvina [dolní/střední/horní] kalichu ... pólu [.. mm] o velikosti ..., echogenní ložisko vrhající akustický stín (artefakt třpytění na barevném Doppleru [přítomen]). Kalichopánvičkový systém [nedilatovaný/dilatovaný].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] v ledvině [.. mm] konkrement; [bez hydronefrózy / s doprovodnou hydronefrózou].

117 POCUS plic · Známky pneumotoraxu

Kdy se používá: Případy po úrazu nebo intervenci, kdy při bedside UZ plic není patrné klouzání pleury. Urgentní hlášení.

Technika: Lůžkový UZ plic; přední hrudní stěna, M-mód.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] na přední stěně hrudníku nezastiženo klouzání plíce (lung sliding); B-linie nepřítomny. V M-módu [příznak čárového kódu/stratosféry]. Bod plíce (lung point) [přítomen/nepřítomen].

Závěr: [Vpravo/Vlevo] známky svědčící pro pneumotorax ([zastižen lung point]). Klinickému týmu [hodin] hlášeno.

118 UZ břicha (děti) · Invaginace

Kdy se používá: Případy, kdy u malých dětí s intermitentní bolestí břicha a zvracením vidíte obraz terče (target sign). Urgentní hlášení.

Technika: UZ břicha; lineární a konvexní sonda.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Pravý horní kvadrant/Pravá polovina břicha] v ..., v příčném řezu obraz terče (target sign), v podélném řezu obraz pseudoledviny vykazující [.. mm] střevní segment o průměru ... Uvnitř [lymfatická uzlina / lead point] [není/je]. Tok ve stěně na barevném doppleru [zachován/snížen]. Volná tekutina v okolí [není/je].

Závěr: [Ileokolická] známky kompatibilní s invaginací. Urgentní nález; klinickému týmu [hodin] hlášeno.

119 Dopplerovský UZ skrota · Epididymoorchitida

Kdy se používá: Případy se skrotální bolestí a otokem, kdy v epididymis vidíte hyperémii.

Technika: UZ skrota v šedé škále a barevný dopplerovský UZ.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Vpravo/Vlevo] nadvarle [hlava/tělo] část zvětšená a heterogenní; na barevném Doppleru výrazně zvýšená vaskularizace. V varleti [hyperémie přítomna/nepřítomna]. Reaktivní hydrokéla [přítomen/nepřítomen]. Kontralaterální varle a nadvarle jsou v normě.

Závěr: [Vpravo/Vlevo] [epididymitida/epididymo-orchitida] nález kompatibilní s... Testikulární perfuze je zachována.

120 UZ měkkých tkání · Absces

Kdy se používá: Pátrání po tekutinové kolekci u případů se zduřením, zarudnutím a bolestivostí podkoží.

Technika: UZ povrchových měkkých tkání; lineární sonda, barevný Doppler.

Porovnání: [datum] porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne [datum]. / K porovnání není k dispozici žádné předchozí vyšetření.

Nález: [Oblast] v podkožní tukové tkáni v … [.. mm] o velikosti …, nepravidelně ohraničená hypoechogenní kolekce s vnitřními echogenitami a kompresí pohyblivým obsahem; v okolí zvýšená vaskularizace a edém (vzhled dlažebních kostek).

Závěr: [Oblast] kolekce odpovídající abscesu měkkých tkání v … a známky periferní celulitidy.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní otevřete Bonus 1 · Databanka 200 závěrů popisu. Nejobtížnější částí šablony je pole Závěr; uzavřete každý popis jednou jasnou větou pomocí vět pro normální, incidentální a akutní nálezy z naší databanky.

Před podpisem **Rychlý bonus · Jednostránkový kontrolní seznam popisu** mějte při sobě.